No existe actualmente evidencia de que baxdrostat reduzca la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Baxdrostat está aprobado por la FDA únicamente para el tratamiento de la hipertensión arterial en combinación con otros antihipertensivos, y su evidencia clínica disponible (BrigHTN, HALO, BaxHTN, Bax24) se centra exclusivamente en reducción de la presión arterial en hipertensión no controlada y resistente.[1][2]

No se han publicado ensayos de desenlaces cardiovasculares duros (mortalidad, hospitalización por insuficiencia cardíaca) con baxdrostat. Están en curso estudios de fase 3 diseñados específicamente para evaluar si baxdrostat, en combinación con dapagliflozina, previene el desarrollo de insuficiencia cardíaca y reduce la mortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida (NCT06742723, NCT06677060), con un criterio de valoración primario compuesto de hospitalización por insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca sin hospitalización y muerte cardiovascular.[3][2] Estos resultados aún no están disponibles.

Por el contrario, para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ≥40%, el antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide finerenona sí cuenta con indicación aprobada por la FDA para reducir el riesgo de muerte cardiovascular, hospitalización y visitas urgentes por insuficiencia cardíaca, lo que ilustra que, dentro de esta clase farmacológica relacionada con el eje aldosterona, es finerenona —y no baxdrostat— la que tiene evidencia de beneficio en mortalidad por insuficiencia cardíaca.[4]

Los autores de los ensayos con baxdrostat señalan explícitamente que, si bien los antagonistas mineralocorticoides (espironolactona, eplerenona, finerenona) han demostrado beneficios clínicos en poblaciones seleccionadas con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, se necesitan ensayos de desenlaces dedicados para determinar si las reducciones de presión arterial logradas con los inhibidores selectivos de la aldosterona sintasa como baxdrostat se traducen en mejores desenlaces cardiovasculares y renales a largo plazo.[2]

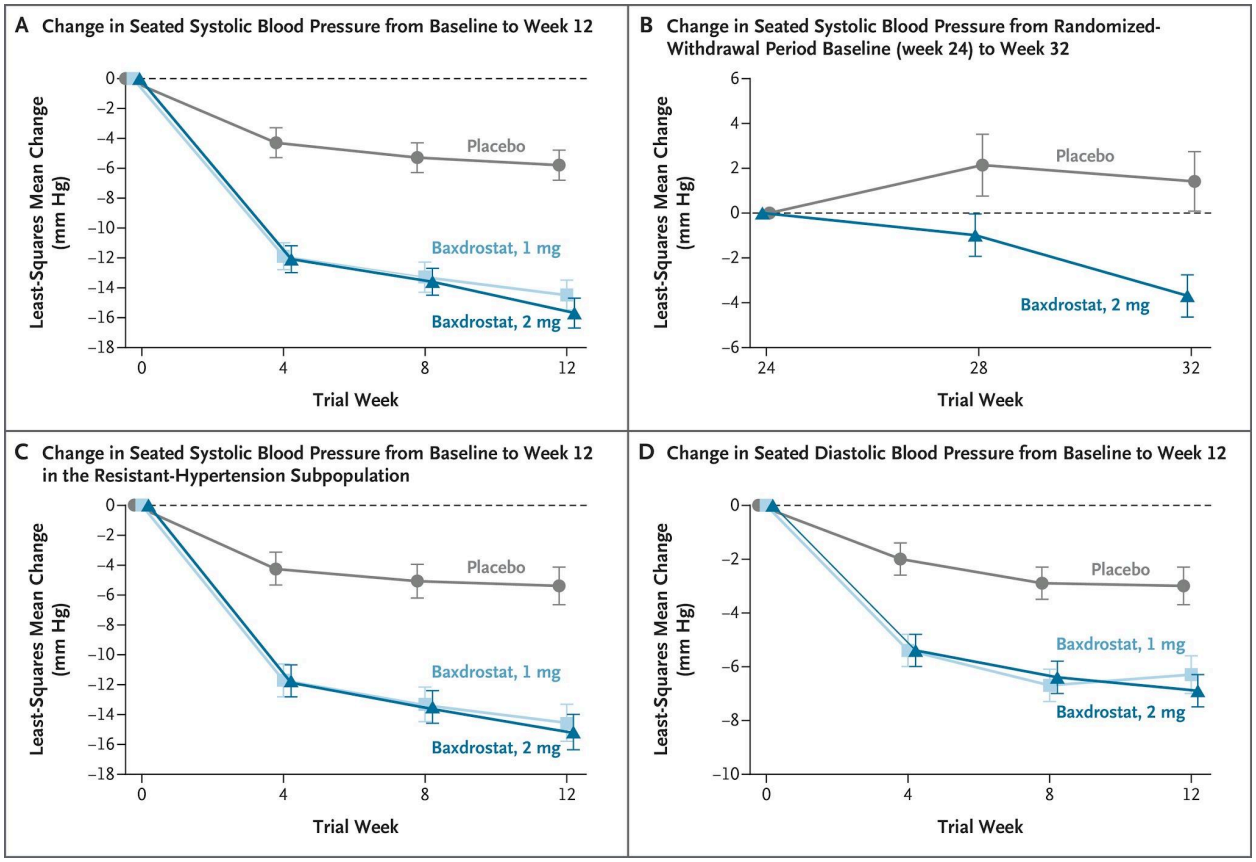


Figure 1 Change in Blood Pressure in Patients with Uncontrolled or Resistant Hypertension. The line graphs show the time course for least-squares mean changes from baseline in the seated systolic blood pressure up to week 12 (Panel A), the change from the randomized-withdrawal baseline (week 24) in the seated systolic blood pressure up to week 32 (Panel B), the change from baseline in the seated systolic blood pressure up to week 12 in the resistant-hypertension subpopulation (Panel C), and the change from baseline in the seated diastolic blood pressure up to week 12 (Panel D). ▯▯ bars on the line graphs indicate standard errors.

¿Le interesaría revisar la evidencia de finerenona en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada?

References

1. Efficacy and Safety of Baxdrostat in Uncontrolled and Resistant Hypertension. Flack JM, Azizi M, Brown JM, et al. The New England Journal of Medicine. 2025;393(14):1363-1374. doi:10.1056/NEJMoa2507109.
2. Effect of Baxdrostat on Ambulatory Blood Pressure in Patients With Resistant Hypertension (Bax24): A Phase 3, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.

Azizi M, Brown JM, Dwyer JP, et al. Lancet (London, England). 2026;407(10532):988-999. doi:10.1016/S0140-6736(25)02549-8.
3. Heart Failure Prevention: Evidence Generation, Trial Design, and Regulatory Pathways. Butler J, Khan MS, Ferreira JP, et al. Journal of the American College of Cardiology. 2026;87(15):1907-1935. doi:10.1016/j.jacc.2025.12.029.
4. FDA Orange Book. FDA Orange Book.